PROPUESTA DE INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA (ICE)

DEPARTAMENTO DE REGISTRO - COMISIÓN EUROPEA (BRUSELAS)

1. DATOS DE LA DENOMINACIÓN PROVISIONAL DE LA ENTIDAD PROMOTORA

• **Siglas Principales:** ANED (Asociación Nacional de Neurodivergencia y Derechos Sociales)
• **Siglas Secundarias / Reserva:** FAND (Federación de Apoyo a la Neurodivergencia y el Desarrollo Inclusivo)
• **Nota:** (Denominación Nacional en Trámite de Registro Centralizado - Reino de España)

2. TÍTULO DE LA INICIATIVA

Directiva Europea de Armonización de la Neurodiscapacidad: Por el Reconocimiento de los Estados Crónicos de Ansiedad, Depresión y Disfunción Ejecutiva como Causa Obligatoria de Adaptación Laboral y Educativa.

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: LA REALIDAD CLÍNICA Y LAS LIMITACIONES DE LA NEURODIVERGENCIA

La presente iniciativa ciudadana denuncia la desprotección jurídica y la discriminación sistemática que sufren millones de ciudadanos europeos con diagnósticos de TDAH, Autismo Nivel 1 y el perfil combinado AuDHD. Los baremos actuales de los tribunales médicos de la Unión Europea están obsoletos: exigen la presencia de una discapacidad intelectual o un retraso del habla visible para otorgar el grado de discapacidad, ignorando que las personas verbales e inteligentes sufren limitaciones orgánicas y psicosociales severas e invalidantes en su día a día.

Vivir en un entorno neurotípico rígido sitúa el sistema nervioso de estas personas en un estado de alerta perpetua (simpaticotonía), lo que cronifica trastornos de ansiedad generalizada, episodios de depresión mayor y burnout destructivo. Las dificultades biológicas y cotidianas que justifican el reconocimiento obligatorio de la discapacidad son:

A. La Disfunción Ejecutiva como Incapacidad Orgánica (TDAH y Perfiles Combinados)

• **Parálisis por Análisis y Bloqueo de Acción:** El déficit biológico de dopamina en la corteza prefrontal impide la correcta regulación cognitiva. El individuo sufre una incapacidad real para iniciar tareas ordinarias o burocráticas (responder correos, rellenar informes, planificar objetivos), lo que cronifica niveles de ansiedad clínica paralizante y sentimientos de indefensión aprendida.

• **Ceguera Temporal Estructural:** Incapacidad neurológica para medir, procesar y percibir el paso del tiempo de forma realista. Esto condena a la persona a retrasos involuntarios crónicos o a vivir en un estado de hipervigilancia extrema y estrés constante para cumplir con las exigencias horarias de las empresas.

• **Labilidad Afectiva y Desregulación Emocional:** El cerebro carece de los filtros biológicos para modular la intensidad de los estímulos emocionales. Un imprevisto menor o una crítica laboral ordinaria se procesan neuroclínicamente como una amenaza extrema, desencadenando crisis de ansiedad agudas o estados depresivos reactivos inmediatos.

B. La Invalidez Sensorial y Social Silenciosa (Autismo Nivel 1 y Perfiles Combinados)

• **Dolor Físico por Hipersensibilidad:** El cerebro autista carece de modulación de entrada sensorial. Los estímulos ordinarios de las oficinas y aulas (luces fluorescentes parpadeantes, murmullos de fondo, sonido de climatizadores) son procesados por el sistema nervioso como una agresión física real y dolorosa, desgastando la energía neurológica del individuo y anulando su capacidad de concentración.

• **El Coste Destructivo del Masking (Enmascaramiento Social):** El sobreesfuerzo consciente, continuo y exhaustivo para imitar conductas neurotípicas, forzar el contacto visual e interpretar dobles sentidos agota la energía vital de la persona. Este camuflaje social es el causante de que, al finalizar la jornada laboral o escolar, el individuo sufra mutismo selectivo temporal, colapsos depresivos por desconexión (shutdowns) o crisis agudas de llanto y rabia (meltdowns) en la intimidad.

• **Rigidez Cognitiva Extrema:** La alteración de directrices o rutinas sin una estructura explícita rompe los esquemas lógicos de organización del cerebro autista, provocando bloqueos del habla completos y crisis de pánico inmediatas.

4. OBJETIVOS VINCULANTES DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA EUROPEA

• **Objetivo 1: Reconocimiento Automático del Grado de Discapacidad.** Obligar a los Estados miembros a otorgar de forma automática el estatus legal de discapacidad (mínimo el 33% o equivalente nacional) a cualquier persona con un diagnóstico clínico oficial de TDAH, Autismo o perfil AuDHD, reconociendo por ley que la comorbilidad con la ansiedad crónica, la depresión y la disfunción ejecutiva es inherente al sobreesfuerzo biológico de adaptación.

• **Objetivo 2: Obligatoriedad de las Adaptaciones Psicosociales y Sensoriales (PRL).** Establecer que las empresas y centros educativos tengan la obligación legal de aplicar ajustes razonables personalizados (flexibilidad horaria, espacios con baja intensidad lumínica y acústica, comunicación explícita por escrito y uso de herramientas digitales de autorregulación ante crisis).

• **Objetivo 3: Régimen de Sanciones Coercitivas a Empresas.** Tipificar la negativa empresarial a realizar estas adaptaciones, o la prohibición de usar herramientas de contención y auriculares de cancelación de ruido, como una infracción laboral muy grave por

discriminación directa, aplicando el régimen sancionador vigente con multas económicas de 30.000 € a 90.000 € (graves) y de 90.001 € hasta 1.000.000 € (muy graves), junto con la pérdida de contratas públicas.

• **Objetivo 4: Implementación del Retorno Económico y Desplome del Paro.** Promover la aplicación del Estudio de Compatibilidad Neurolaboral de nuestra asociación (ANED / FAND). Demostrar ante las instituciones que, cuando se adaptan las condiciones sensoriales y se encauzan los perfiles hacia puestos que potencien el hiperfoco (programación, análisis de datos, investigación, estrategia o arte), las empresas aumentan su rentabilidad, las bajas médicas por salud mental en la Seguridad Social se reducen a cero y se rescata a un colectivo que actualmente sufre un 90% de desempleo o precariedad crónica.

PROPUESTA IMPULSADA POR:
ANED / FAND (Denominación Nacional en Trámite de Registro Centralizado - España).
Con el apoyo técnico y el asesoramiento de la red de profesionales neurodivergentes de la salud mental, la prevención de riesgos laborales y la inserción social comunitaria.